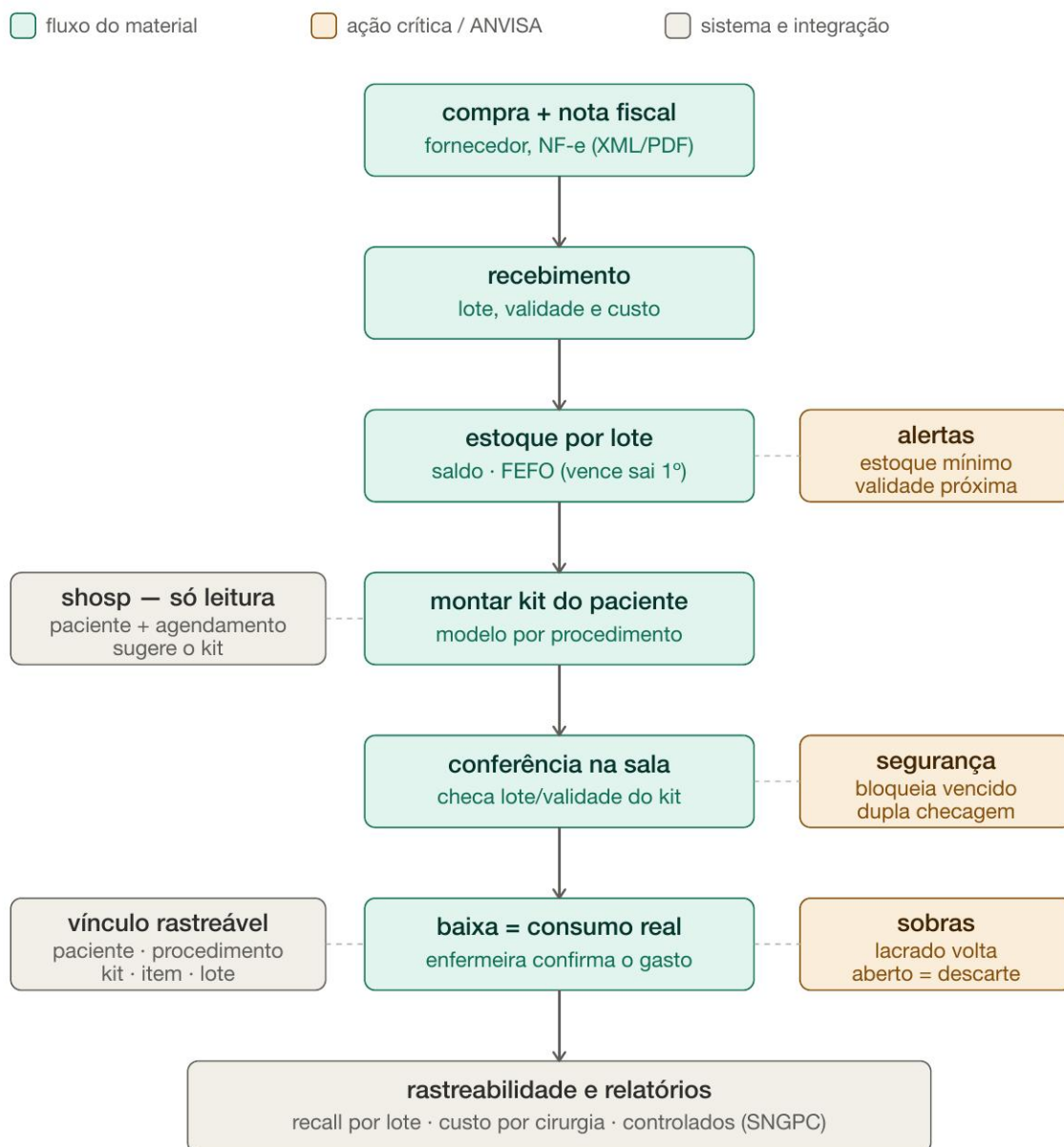


Sistema de estoque e kits cirúrgicos

Proposta de funcionamento para validação da enfermagem. O controle de estoque passa a fazer parte do mesmo sistema da clínica (mesmo login, mesmo cadastro de paciente, mesma agenda Shosp), controlando cada material — da compra até o que é usado no paciente.

Como funciona — do fornecedor ao paciente



O que muda na prática

A baixa do estoque é a enfermeira que confirma — item a item, depois da cirurgia (o "fechamento da sala"). A agenda da Shosp e o funil apenas **sugerem e pré-preenchem** o kit; eles não dão baixa sozinhos. É isso que mantém o sistema sempre igual à prateleira física.

- **Entrada por lote e validade:** toda compra entra com nota fiscal, lote, validade e custo. Nada entra "solto".
- **FEFO automático:** ao usar, o sistema já indica o lote que vence primeiro.
- **Kit por procedimento:** modelos prontos (ex.: "Kit FUE até 3.000 folículos") montam a cirurgia em um clique, com ajuste do que for específico daquele paciente.

- **Rastreabilidade total:** em segundos responde "qual lote este paciente recebeu?" e "quais pacientes receberam o lote X?" (base para recall do fornecedor).
- **Alertas:** avisa quando um item está acabando (estoque mínimo) ou perto de vencer.
- **Controlados:** anestésicos/controlados ganham livro próprio para o SNGPC/ANVISA, com dupla conferência.
- **Custo por cirurgia:** quanto de material cada procedimento e cada paciente consumiu.

Etapas de entrega (para o orçamento)

ETAPA	O QUE ENTREGA	ESFORÇO
1 · Fundação	Cadastro de itens e fornecedores, entrada por nota, lotes, saldo, FEFO, permissões. A clínica já sabe o que tem, por lote e validade.	Grande
2 · Kits + paciente + baixa	Modelos de kit, montar kit do paciente, conferência na sala, baixa por confirmação, rastreabilidade lote ↔ paciente.	Grande
3 · Alertas, controlados e relatórios	Alertas de mínimo/validade, livro SNGPC, recall por lote, custo por cirurgia/paciente.	Médio
4 · Integrações (opcional)	Casar com Bling/NF-e, registro no prontuário, cadeia de frio, instrumental reutilizável.	Médio

Decisões a confirmar antes (risco regulatório/operacional)

- **Controlados (ANVISA):** confirmar com a vigilância/responsável técnico se a clínica transmite SNGPC ou mantém livro próprio. Lidocaína pura não é controlada — o relevante é a associação com vasoconstritor e os sedativos.
- **Frasco multidose:** abre 20 ml, usa 12, descarta 8 — o resto não volta ao estoque (unidade de compra × unidade de uso).
- **Devolução × descarte:** só item lacrado volta ao lote; item aberto = descarte obrigatório.
- **Reserva com expiração:** paciente que falta/remarca libera o material reservado automaticamente.

Para a enfermagem validar

- 1 Você monta o kit **antes** da cirurgia (separa o material) ou só registra **depois** o que foi usado?
- 2 Quais materiais são **controlados/anestésicos** e precisam do livro SNGPC? Precisa de nº de receita/prescritor?
- 3 Quais itens controla por **lote e validade** obrigatoriamente, e quais não vale a pena (ex.: gaze)?
- 4 Qual a **unidade** de cada item que importa — anestésico por frasco ou por ml? luva por par ou caixa?
- 5 Tem **instrumental reutilizável** (punch, caneta FUE) com controle de esterilização, ou no início basta descartável e medicação?
- 6 Já tem **modelos de kit** por tipo de cirurgia? Quais itens e quantidades entram em cada?
- 7 Quantos dias antes do vencimento quer ser **avisada** (30/60/90)? Qual estoque mínimo dispara recompra?
- 8 **Sobras** (frasco aberto, gaze não usada) voltam ao estoque ou são descartadas?
- 9 Algum material exige **refrigeração** (cadeia de frio)?
- 10 O **custo do material** entra na conta de quanto cada cirurgia custou (margem), ou é só controle físico?
- 11 **Quem** pode dar entrada, montar kit e dar baixa — todas as enfermeiras ou só a coordenação?